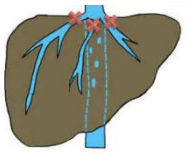
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.门脉高压的机制 肝炎肝硬化的“肝内”



❌不是窦前阻塞

①窦**前**性：肝内肝动脉-门静脉**异常吻合支**

②**窦性**阻塞：肝血**窦**受压

假小叶形成后导致肝静脉受压❌因为肝静脉已经出肝

③**窦后**性阻塞：**中央静脉**和**小叶下静脉**受压（不是肝静脉、肝静脉在肝后）

血吸虫肝硬化

注意：**肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞**，而**血吸虫**肝纤维化主要为**窦前**阻塞（血吸虫虫卵较大进不去肝血窦→虫卵沉积于门管区→肝内门静脉周围纤维化→较显著门脉高压）

淤血、胆汁、血吸虫肝纤维化肝细胞坏死程度没有病毒性肝炎严重，所以假小叶和再生结节相对较少

2.门脉高压的临床表现

①**侧枝循环形成（最特征/价值）：食管胃底/直肠/腹壁等静脉曲张（可形成海蛇头）**

②**淤血性脾大（最早）、脾亢** 脾静脉和肠系膜上静脉构成门静脉主干(解剖学)

大量脾静脉血往门静脉回流

③**胃肠淤血和水肿** 门脉高压→腹腔血液回流障碍→血液淤积在小静脉和CAP→细胞长期缺氧→变性坏死→血管壁通透性↑

④**腹水（漏出液）：静水压和通透性↑、淋巴液外溢、血浆胶渗压↓、醛固酮和 ADH 灭活↓、有效循环血量↓**

门脉高压　肝功能不全

恶性循环:肾血流量↓→RAAS系统激活→加重水钠潴留

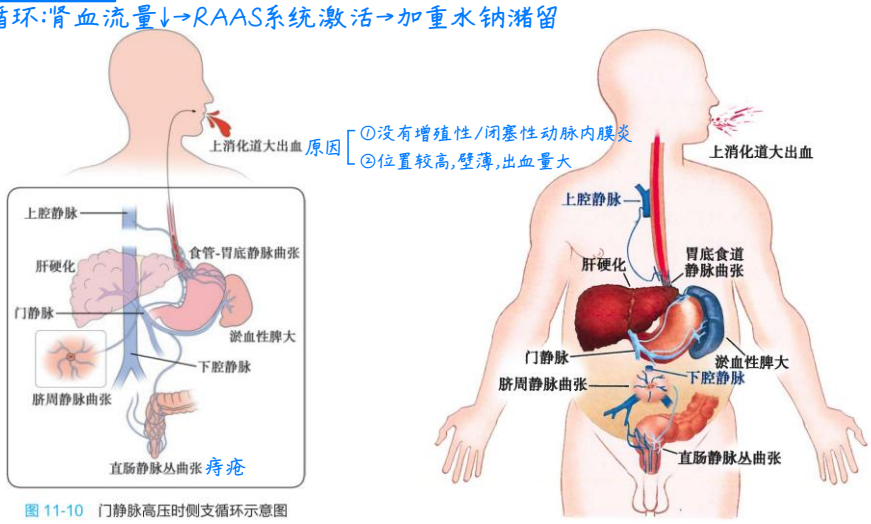


图 11-10　门静脉高压时侧支循环示意图

